

--- Seite 1 ---

Seite 1 von 10 Verlaufsdocumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

30.01.2026

Aufwecken, Anregen 08:30 - 10:10

1. Orga 2. Feedback Ü-Gruppe 3. Psychoedukation bzgl. Beziehung zum Phänomen 4. Psychoedukation zu Anteilen und Identifizierung 5. Entscheidungen: Die Beziehung zu sich selbst 5.1 Psychoedukation zum Symptom 6. Entscheidungsfindung und Anteildialog 7. Einführung Eigenarbeit
hat teilgenommen

Bahnen, Verankern 10:10 - 11:45

hat teilgenommen

Beobachten, Integrieren 11:50 - 12:40

1. Check-in - Wie haben sie entschieden, die Zeit zu nutzen? 2. Wie fühlt sich jetzt das Wort "Entscheiden" an? 3. Abschlussrunde zum Mut machen IM: Wollte eigentlich schon abgereist sein, ist für die Gruppe dann noch da geblieben. Hat "in ihr Herz gehört und ein Bedürfnis gefunden". Hat einen Preis, den sie bewusst eingegangen ist.

hat teilgenommen

29.01.2026

Aufwecken, Anregen 09:15 - 10:55

Kurzes Blitzlicht, dann Übergang zum Thema von Heute anhand von Bildkarten, die Sie verdeckt gezogen haben, und kurz teilen was Sie jetzt erleben. In der Zeit von bahnen verankern, erstmal für sich im Prozess sein und dann zu zweit oder mit mehreren in einen Austausch gehen.

hat teilgenommen

Abschlusskontakt (C.Weber) 11:30 - 11:40

Anspruchsvolle Übergangsgruppe Wiedererleben von Familiären Themen: Jetzt werde ich hier in die Ü geschmissen gegen meinen Willen, fühle mich noch gar nicht bereit. Ich mag es hier nicht usw. Sonntag dann Muttermahl entdeckt, Angst vor Ausbruch des Hautkrebs, Gedanken an Abreise zur Abklärung, Angst, Panik Dann Zwischenraum in ihr entstanden mit der Entscheidung, ich bleibe hier für mich Im Laufe der Ü -Woche dann Erkenntnis, es war genau was es braucht als Vorbereitung, nochmal zu Üben, wie geht es für sich zu Sorgen und Freude in Verbundenheit zu erleben, auch wenn der Kontext es scheinbar unmöglich macht. Geht sehr gut und erfüllt mit der Idee zu gegebener Zeit wieder zu kommen. Klientin glaubhaft absprachefähig, keine Anzeichen von akuter Suizidalität

hat teilgenommen

Bahnen, Verankern 11:50 - 12:40

hat teilgenommen

Beobachten, Integrieren 15:00 - 15:50

Check-In- "Wie war der Tag bis jetzt?" MI: Ist Müde, haben sich in der Gruppe schon viel über die Bilder unterhalten

hat teilgenommen

28.01.2026

Beobachten, Integrieren 14:00 - 14:50

Einheit à 100 Minuten. Einstiegsrunde. Einführung Thema "Umgang mit Ehrenrunden". Vorstellen von Angeboten, Gr. entscheidet sich für Arbeit mit Skizzen, die als Bodenanker genutzt werden. -neutrale Position -Bild für "Ehrenrunde" -Bild mit erwarteter innerer Reaktion auf "Ehrenrunde" -Bild mit gewünschter innerer Reaktion auf "Ehrenrunde" Abschlussbesprechung. Frau M.I. bringt unterschiedliche Themen in die Gruppe ein. Immer wieder Reflexion bzgl. Sinnhaftigkeit der Ü für sie, z.T. mit abwertender Tendenz. Ich beziehe dazu Stellung. Frage nach: wie kann ich in Selbstwirksamkeit kommen, wenn Umgebungsbedingungen nicht deckungsleich mit eigenen Bedürfnissen? Sie benennt herausfordernde Situation für sich vor einigen Tagen, wo sie kurz vor Abreise gestanden habe. Sie sei nun froh, geblieben und durch das Thema durgegangen zu sein. Bedankt sich zum Ende der Stunde.

hat teilgenommen

27.01.2026

Aufwecken, Anregen 08:30 - 10:10

1. Check-In, reflexion der gestrigen Gruppen 2. Hypnose - Wie ist es hier und jetzt? 3. Welchen Lerneffekt nehme ich mit 4. Psychoedukation: Seitenmodell und Kybernetik - Bild der verschiedenen Anteile, mit Beobachter und Beobachteter des Beobachters. 5. Psychoedukation Aufmerksamkeitsfokussierung - Bild eines Leuchtturms mit dem Scheinwerfer 6. Vorstellung Selbstübungen - Inquiry, Timeline, Sowohl-als-auch oder Freiarbeit MI: Hat sehr viel Respekt davor, ohne T. zu sein. Hat hier das schönste Geschenk ihres Lebens gefunden. Konnte sich selbst erkennen mit allen Anteilen.

hat teilgenommen

Bahnen, Verankern 11:50 - 12:50

hat teilgenommen

--- Seite 2 ---

Seite 2 von 10 Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

27.01.2026

Beobachten, Integrieren 14:00 - 14:50

1. Check-in - Wie war der Nachmittag? 2. Vorstellung des digitalen Übergangsraum MI: Hat Inquiry alleine gemacht. Erhält von der Antwort auf die erste Frage. Sagt: Wenn ich beginne, andere Menschen zu bewerten, dann bin ich automatisch zu mir auch nicht freundlich.

hat teilgenommen

26.01.2026

Aufwecken, Anregen 08:50 - 10:30

1. Check-in - Wofür bin ich in der Ü-Gruppe? 2. Thema heute: Bilanz ziehen. Welche Themen waren präsent? Was war besonders hilfreich? Welche Kernbotschaft nehme ich mit? 3. Hypnose. Mein Gefäß, was ist dort drin? 4. Visualisieren der Bilder, welcher in der Trance kamen 5. Einleitung in Eigenarbeit 6. Check-out - Überschrift von der Visualisierung MI: Möchte Sachen aus ihrem Gedächtnis hier lassen. Fühlt sich stabil, freut sich auf Zuhause. Ist aber auch Angstbesetzt. Check-out: Möchte nicht verharren, sondern andere Perspektiven zulassen.

hat teilgenommen

Bahnen, Verankern 11:00 - 11:50

hat teilgenommen

Beobachten, Integrieren 14:00 - 14:50

Reflexion der Gruppenübung und der visuellen Übungen MI: Ist froh darüber, das Anteilemodell kennen gelernt zu haben. Kann sich so besser selbst akzeptieren. Möchte den Fokus auf das "jetzt" legen. Ist sehr stolz auf sich, dass sie bis jetzt in der Klinik geblieben ist.

hat teilgenommen

25.01.2026

Krisengespräch Medizinisch (Y.Yilmaz)

Kommt in die Medizin und ist sehr verunsichert - sie ist Melanompatientin und hat schon diverse Muttermale entfernt bekommen - sie hat am Sprunggelenk eines entdeckt das ihr nicht gefällt und möchte am liebsten heute noch abreisen, damit sie morgen zu ihrer Hautärztin gehen kann - sie wird später ein Gespräch mit der Dienstärztin führen und dann entscheiden wie sie es handhaben möchte - sie wäre ab morgen in der Ü-Gruppe

hat teilgenommen

Beratung - ausführlich (Dr.K.Mustermann) 13:20 - 13:30

Klientin (Melanom-Patientin, Selbstzahlerin, ab morgen Ü-Gruppe) hat kürzlich am re dist. Unterschenkel eine neue Hauteffloreszenz (ca. 0,2-0,3 cm mit winziger dunklerer Erhabenheit) entdeckt. Mit ihrer Dermatologin sei sofortige Rücksprache bei Verdacht. Nävi vereinbart worden; sie wolle daher heute abreisen, um ihre Dermatologin morgen (Mo) konsultieren zu können (telefonisch oder per e-mail sei die Praxis schwer erreichbar, Do seien die OP-Tage). Vereinbarung: erneuter Kontakt nach Rückspr. Hintergrund.

hat teilgenommen

Beratung - kurz (2 Min.) auch telefonisch (Dr.K.Mustermann) 14:10 - 14:12

Telefonkontakt nach Rückspr. psychiatr. Hintergrund (Jochen): Klientin möchte nun doch nicht mehr abreisen,

sondern Dermatologin morgen kontaktieren und ansonsten an der Ü -Gruppe teilnehmen -die habe für sie jetzt
Priorität

hat teilgenommen

23.01.2026

Bezugsgruppe08:10 - 10:40

Therap.: H.Conrad, BQTlerin L.Lehmann Einsammeln: wie gehe ich ins Wochenende? Einstiegsangebot:

Ich als Teil eines Ganzen freies Arbeiten Werkreflexion Frau M. empfinde Freude aufs WE, wolle sich Zeit für sich nehmen (Erkenntnis: sie brauche sehr viel Zeit für sich). Rückblick Thema Masken: sie wolle keine Maske vor ihrem Gesicht haben. In ihren Werken male sie klare Grenzen, jedoch weiche und teils offene. Habe ihre "Inseln" gemalt, die komplex und in Bewegung seien.

hat teilgenommen

22.01.2026

Prozessreflexion14:00 - 15:30

orga produkt Info BL und PRs Frau M. habe während dem Aufenthalt ihren Selbstwert neu kennengelernt, sei mittlerweile in einer Liebensbeziehung zu sich selbst. "I<3 me" Erhält die Resonanz es sei spürbar wie sie zu sich selbst gefunden habe und auf ihre eigenen Bedürfnisse achte.

hat teilgenommen

Beratung - ausführlich (EM.Musterwald)16:45 - 16:55

Klientin wünscht sich eine phytotherapeutische antidepressive Therapie, hatte schon von Laif° erfahren; nach
hat teilgenommen

--- Seite 3 ---

Seite 3 von 10Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

22.01.2026

meinem Dafürhalten spricht nichts gegen die Einnahme von Laif° 900 mg morgens Hinweis auf Lichtschutz entfällt insofern, als Frau M. wegen Z.n. MM sowieso UV-Strahlung meidet

21.01.2026

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

Therap.: B.Rüdiger, BQTlerin L.Lehmann 1. Orga 2. Anliegen sammeln 3. Angebot: Bewegung und Visualisierung >> Impulse und Bedürfnisse wahrnehmen und umsetzen - Themen: wer bin ich? welche Steuerung? Prozessverlauf und diesen begleitende Instanzen 4. Austausch Frau I. M.beschäftige das Thema sich selbst Zeit für sich und Entspannung zu nehmen - das wolle sie in den Vordergrund stellen. Energiequelle: Natur beobachten, sich frei bewegen. Auf Unwohlsein erster Impuls Aushalten - dann Erkenntnis: "ich kann ja auch gehen".

hat teilgenommen

Gruppe non-verbal 214:00 - 15:40

Therap.: C.Beck, BQTlerin L.Lehmann Info zu Musiktherapie für neue Klientin Klangtrance mit vorheriger Einladung zur inneren Ausrichtung >>> Austausch, Reflexion: aufkommendes Erleben, Bilder, Impulse etc. erneuter Klangimpuls für den restlichen Tag (auf Wunsch der KlientInnen) Frau M. habe während der Trance eine Ausrichtung zu sich selbst und dem eigenen Körpererleben erlebt und dies als angenehm empfunden.

hat teilgenommen

20.01.2026

Bezugsgruppe08:30 - 10:10

Therap.: C.Weber, L.Falke, BQTlerin (L.Lehmann) Anliegen Sammlung Thema: Selbstentwicklung in Beziehung - was ist bei mir, was beim Gegenüber - eigene Schutzanteile - Rückzug vs. in Beziehung gehen; Vertrauen in Prozess Frau M. beteiligt sich aktiv am Gruppenthema.

hat teilgenommen

Einzelgespräch (C.Weber)14:00 - 14:50

Auftragsklärung: Frau M. berichtet nach einem Aufenthalt bei den Eltern von einem deutlich veränderten inneren Erleben. Ziel des Gesprächs ist die Einordnung dieser Entwicklung, das Vertiefen des neu gewonnenen Selbstbezugs sowie die Klärung, wie sie mit alten Beziehungs- und Funktionsmustern (v. a. in Herkunftsfamilie, Partnerschaft und Gruppe) künftig freier umgehen kann. Relevante Gesprächsinhalte: Frau M. beschreibt

berührende, seltene Momente von emotionaler Resonanz mit den Eltern und hebt hervor, erstmals konsequent sich selbst in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Sie erlebt eine deutliche Reduktion von Angst und eine neue, spielerisch-distanziert wertschätzende Haltung gegenüber inneren Anteilen. In Gruppensituationen gelingt es ihr zunehmend, Grenzen wahrzunehmen und zu setzen (z. B. Verlassen belastender Situationen), ohne sich dafür zu verurteilen. Gleichzeitig wird ein alter, sehnsüchtiger Anteil sichtbar, der gesehen und emotional bestätigt werden möchte – insbesondere in der Beziehung zum Vater und zum Ehemann. Das bisher dominante Muster von Anpassung, Wachsamkeit und Funktionieren verliert an Steuerungsmacht zugunsten von Selbstwahrnehmung, Selbstschutz und innerer Erlaubnis. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven: Die aktuellen Veränderungen werden als Ergebnis eines tragfähiger gewordenen inneren Bezugs und einer Integration bislang abgespaltener Bedürfnisse verstanden. Angst und Rückzug erscheinen nicht mehr primär als Störsymptome, sondern als sinnvolle Schutzreaktionen, die nun regulierbar sind.

Entwicklungsperspektivisch steht im Vordergrund, die neue innere Sicherheit zu stabilisieren, ambivalente Gefühle auszuhalten und Beziehung nicht mehr über Selbstaufgabe zu regulieren. Rückfälle in alte Muster werden als erwartbare Lernfelder eingeordnet, nicht als Scheitern. Einladungen: Einladung zur weiteren bewussten Arbeit mit inneren Anteilen (insbesondere dem sehnsüchtigen, gesehen -werden-wollenden Anteil); Übung im liebevollen Daseinlassen von Gefühlen ohne Handlungsdruck; fortgesetztes Setzen und Nachspüren von Grenzen in Gruppe und Alltag; kurze Selbstgespräche oder innere Dialoge zur Selbstberuhigung; achtsames Beobachten von Stolz- und Vertrauensmomenten als Ressource.

hat teilgenommen

19.01.2026

Bezugsgruppe mit Wochenausrichtung 08:30 - 10:30

Therap.: C. Saur, L. Falke, BQTlerin (L. Lehmann) 1. Orga: BL, ... 2. Ausrichtung: 2 Gegenstände suchen -symbolisch für einen Wunsch für die Woche, und einen möglichen würdigen Preis, den sie dafür

geben/loslassen würden 3. Einsammeln Frau M. wolle weiterhin ihre Anteile in ihrer Unterschiedlichkeit und Imperfektion annehmen (Steine in goldener Schale). Was sie mitnehme sei "ein Ast, der Wurzeln schlagen und austreiben kann", an welchem all ihre Anteile "baumeln" würden. Bei dieser Beschreibung strahlt sie.

hat teilgenommen

Körperarbeit Einzel (B. Schmitt) 11:15 - 12:00

Körperarbeit bei B. Schmitt-Demir Köa. mit Hilfe des Anteilemodells. mit dem Fokus auf "Schwingungsfähig bleiben". Frau I.M. erlbe es als hilfreich, dass sie jetzt Ideen/ Übungen habe, die ihr helfen, wenn sie sich "überflutet fühle. Diese Handlungsfähigkeit auf der körperl. Ebene wahrzunehmen mache sie sehr zuversichtlich. Sie könne gut gehen und bähchte für heute nichts weiter.

hat teilgenommen

16.01.2026

--- Seite 4 ---

Seite 4 von 10 Verlaufsdocumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

16.01.2026

Bezugsgruppe 08:10 - 10:40

Anwesend: H. Conrad, BQTlerin L. Lehmann WE-Bahnung ideensammeln Einstiegsangebot: Masken gestalten Freie Arbeit Werkreflexion Frau M. freue sich auf daheim. Sie gestaltet ein Bild was ihre verschiedenen Anteile darstelle, diese dürften so sein wie sie sind, müssten nicht perfekt sein und nicht harmonisieren. Außerdem gestaltet sie teilweise Grenzen zwischen den Anteilen. Thema Abgrenzung und Verbindung. Das Bild wirkt ordnend, ein Überblick gebend.

hat teilgenommen

15.01.2026

Körperarbeit Einzel (B. Schmitt) 09:15 - 10:00

Körperarbeit bei B. Schmitt Frau I.M. gehe es sehr gut. Sie arbeite gerade an ihren Themen und fühle sich auch im Bezug auf "Tauma" gut begleitet. Für hier habe sie den Wunsch auf das Thema "Grenzen setzen/ Verantwortung abgeben" schauen, da sie im Kontakt mit einer Mitkl. diesbezüglich mit diesen Themen konfrontiert wurde. Biete ihr mit Hilfe des Anteilemodells zunächst eine Art Sortierung und Draufsicht an. Dabei zeigt sich am Ende, dass es bei Frau M. gerade um die Bedürfnisse wie Autonomie, Stabilität und Selbstliebe

gehe. Biete ihr dann noch Ideen auf der Körperebene an im Bezug auf diese Bedürfnisse. Frau M. könne gut gehen und wolle die Übungen gerne ausprobieren.

hat teilgenommen

Prozessreflexion 14:00 - 15:30

orga produkt Info BL und PRs PR Gruppe: Gruppe scheint arbeitsfähig. Frau M. berichtet von ihrer Belastungsprobe am kommenden Wochenende. Sie fühle sich dafür gut vorbereitet, verspüre Freude und Neugier. Je nach Ausgang dieser wolle sie ggf. ihren Aufenthalt noch verlängern. Ihr Ausblick sei aufrechterhaltene Stabilität.

hat teilgenommen

14.01.2026

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

Therap.: B.Rüdiger, BQTlerin L.Lehmann Anfangsimpuls: Bewegung verbunden mit Rhythmus, Verbindung mit Körper Themen: Rückzug und Sein in der Gruppe, Sich in Gruppe zeigen, Relevanz der Beobachtungs/Steuerungsposition, Anteile -Aufstellung Frau M. zeigt sich in Gruppe mit vorhandenen Gefühlen, ihrer "Schwäche" (hinsichtlich bevorstehende Belastungsprobe Eltern besuchen). Dies sei neu für sie.

Aufstellung der eigenen Anteile (Autonomie, reguliertes Selbst, Angst, Trauer, Liebe) und Eltern. Endbild: Eltern in Ballon an Seil - Verbundenheit, aber Möglichkeit "Leinen loszulassen" - damit in Verbindung gehen "was taugt". Sei in gutem Kontakt zu Beobachtungs - und Steuerungsposition, dadurch klar und entscheidungsfähig. Erlebe darüber Freude und Stolz.

hat teilgenommen

Gruppe non-verbal 214:00 - 15:40

Therap.: C.Beck, BQTlerin L.Lehmann Anfangsimpuls: Stimme und Atem (gemeinsam Vokale tönen)

Anliegen: durch Tönen Kontakt zu Verlust des Selbstvertrauens in eigene Fähigkeiten im Beruf >> Resonanz der anderen einsammeln Ausklingen: frei Musik machen - Instrument das mit eigenem Thema in Resonanz geht Frau M. scheint aktiv am Gruppenprozess teilzunehmen. Fühle sich durch das Tönen energetisiert, während des Tönens seien bildhafte Vorstellungen (Weg) entstanden. Erlebe starkes Bedürfnis der Fürsorge für Mitklientin.

hat teilgenommen

13.01.2026

Bezugsgruppe 08:30 - 10:10

Anwesend: C.Weber, L.Falke, BQTlerin L.Lehmann Orga Einsammlung und in Kontakt gehen mit Mikro -Anliegen der Gruppe >> Über-Themen: Gruppendynamik, in Beziehung gehen, Raum einnehmen, Scham in

Gruppe Frau M. sei hinsichtlich der Gruppendynamik mit verschiedenen Anteilen in Kontakt gekommen. Ein Anteil habe Angst, zu viel Raum zu nehmen, ein anderer verspüre Wut, dass andere nichts von sich teilen würden und ein weiterer Anteil nutze gerne den Raum sich zu zeigen und Themen zu bearbeiten.

hat teilgenommen

Einzelgespräch (C.Weber) 11:00 - 11:50

Auftragsklärung (Thema und Ziele des Gesprächs): Frau M. reflektiert ihren bisherigen Therapieverlauf (nach ca. vier Wochen) und thematisiert insbesondere die Frage eines möglichen Besuchs bei ihren Eltern. Ziel des Gesprächs ist es, innere Ambivalenzen (Bindungswunsch vs. Schutz vor Überforderung), Angst - und Schutzanteile sowie Verantwortung und Selbstfürsorge differenziert zu betrachten. Im Fokus steht, Klarheit über Ziele, Erwartungen und innere Zustände zu gewinnen, um selbstbestimmt entscheiden und handlungsfähig bleiben zu können – ohne sich zu überfordern oder alte Muster zu reproduzieren. Relevante Gesprächsinhalte: Frau M. beschreibt eine zunehmende innere Klarheit und Selbstwahrnehmung, gleichzeitig aber anhaltende innere Konflikte. Zentral ist der Wunsch, die Eltern zu sehen und Liebe zu spüren, verbunden mit Angst vor erneuter emotionaler Überforderung durch elterliche Streiddynamiken. Sie erlebt dabei starke Regression (Erleben eines „achtjährigen Anteils“), Ohnmacht, Ekel-/Unruhegefühle sowie innere Fluchtimpulse. Parallel zeigt sich eine deutliche Entwicklung im Umgang mit inneren Anteilen: Gefühle werden häufiger erkannt, hat teilgenommen

--- Seite 5 ---

Seite 5 von 10 Verlaufsdocumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

13.01.2026

benannt und zugelassen, ohne sofort in Aktionismus oder Vermeidung zu gehen. In Gruppensituationen werden Themen wie Selbstwert, Vergleich, Stolz, Schutz anderer, Grenzsetzung (z. B. Nähe/Umarmung), Verantwortungsabgrenzung und authentischer Selbstausdruck intensiv reflektiert. Ein Beispiel aus der Kunsttherapie verdeutlicht Schutzmechanismen (Nicht-Zeigen eines gelungenen Bildes), die aus Rücksichtnahme und eigener Verletzlichkeit entstanden sind. Das Thema innerer Ambivalenzen auf welche Art und Weisen: Sicherheit erlangt werden könnte zieht sich als roter Faden durch das Gespräch. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven: Die Ambivalenz gegenüber dem Elternbesuch wird als Konflikt zwischen kindlichem Bindungsbedürfnis und erwachsener Selbstschutzfunktion verstanden. Angst-, Ekel- und Rückzugsreaktionen erscheinen als körperlich verankerte Schutzreaktionen auf früh erlebte emotionale Unsicherheit. Fortschrittlich ist die wachsende Fähigkeit, diese Zustände wahrzunehmen, ohne sich vollständig mit ihnen zu identifizieren. Entwicklungsperspektivisch geht es darum, Ziele klar zu definieren (z. B. „Ehre zeigen“ vs. „harmonischen Besuch erleben“), Verantwortung realistisch zuzuordnen (was liegt bei mir, was nicht) und innere Sicherheit weiter zu stärken, sodass Nähe möglich wird, ohne Selbstverlust oder Überforderung. Ebenso steht die Integration von Selbstwert, Freude und Sichtbarkeit im Kontakt mit anderen im Fokus. Einladungen (Todos, Aufgaben, Übungen) Klärung des Ziels eines möglichen Elternbesuchs (wofür gehe ich hin, was ist realistisch erreichbar?) Bewusstes Wahrnehmen und Regulieren regressiver Zustände (Kind - vs. Erwachsenen-Selbst) Weiterführende Arbeit mit Angst-, Schutz-, Stolz- und Rücksichtnahme-Anteilen Üben von authentischem Selbstausdruck in Gruppen bei gleichzeitiger Selbstfürsorge Reflexion von Verantwortungsgrenzen (eigene Gefühle vs. Gefühle anderer) Nutzung der Gruppe zur Vorbereitung und Nachbesprechung belastender Situationen

12.01.2026

Bezugsgruppe mit Wochenausrichtung 08:30 - 10:30

Anwesend: L.Falke, C. Saur, BQTlerin L.Lehmann Orga: BL, ... Ausrichtung mit Trance zu Bin -Wunsch-Soll-Befürchtetes Ich und Auswirkungen auf Körper/Gefühle Einsammeln Frau M. beteiligt sich aktiv am Gruppengeschehen. habe von der Trance profitiert, habe einen guten Zugang zu den versch. Ichs finden können. Ihr sei u.a. immer wieder Abstand von inneren "Erwartungen wie alles mitbekommen zu müssen" gelungen. Wünsche sich Begleitung beim Umgang mit dem befürchteten Ich, benennt dieses noch nicht inhaltlicher (würdigen hierbei den Eigenschutz, der ihren eigenen Angaben zufolge auch schon abgenommen habe).

hat teilgenommen

09.01.2026

Bezugsgruppe 08:10 - 10:40

WEBahnung ideensammeln Orga Einsteig: Postkarten gestalten nach kurze Imagination Freie Arbeit Werkreflexion Gestalt liebevoll eine Karte mit goldenen Kern und goldener Umrandung. Sie möchte die Karte nicht mitteilen und Resonanz aus der Gruppe bekommen. Beeiligt sich rege an Austausch.

hat teilgenommen

08.01.2026

Einzelgespräch (C.Weber) 10:45 - 11:35

Auftragsklärung (Thema und Ziele des Gesprächs): Frau M. thematisiert wiederkehrende Angsterlebnisse, Kontrollverlust und innere Konflikte im Umgang mit belastenden inneren Anteilen. Zentrales Anliegen ist die Frage, ob alle inneren Anteile akzeptiert bzw. „gemocht“ werden müssen, sowie der Wunsch nach innerer Sicherheit und Selbstführung auch außerhalb geschützter therapeutischer Settings. Ziel des Gesprächs ist es, das innere Erleben zu ordnen, Angst- und Kontrollthemen einzuordnen und einen differenzierteren, entlastenden Umgang mit den Anteilen zu entwickeln. Relevante Gesprächsinhalte: Frau M. beschreibt ein plötzliches Wiederauftreten intensiver Angstzustände mit Kontrollverlust, innerer Dunkelheit und starker Verunsicherung, ausgelöst durch einen inneren Anteil, der bestehende Stabilität infrage stellt. Dies führt zu Angst vor Hilflosigkeit und erneuter Destabilisierung. Gleichzeitig zeigt sich ein stark kontrollierender, bewertender Anteil, der Angst nicht zulassen will. Biografisch berichtet Frau M. von einer durch Angst, Kontrolle und emotionale Unsicherheit geprägten Kindheit mit einem cholerischen, unberechenbaren Vater, strengen Regeln, frühem Verantwortungsübernehmen und fehlender emotionaler Sicherheit. Gewalt, Kontrolle, Lügen als Anpassungsstrategie sowie kulturell bedingte Geschlechterrollen prägten ihr Autonomie- und Bindungserleben. Im Erwachsenenleben zeigen sich diese Muster u. a. in einer hochbelasteten Partnerschaft mit

alkoholabhängigem Ehemann, Co-Abhängigkeit, starken Loyalitätskonflikten und dem Aufbau äußerer Sicherheitsstrukturen (eigene Wohnung, klare Grenzen), bei gleichzeitiger innerer Ambivalenz. Die Arbeit mit inneren Anteilen wird als hilfreich, aber auch anstrengend erlebt. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven: Die Angstsymptomatik wird als Aktivierung traumabezogener innerer Anteile verstanden, die auf früh erlebte Kontrolllosigkeit und fehlende Sicherheit reagieren. Der kontrollierende, abwertende Anteil dient dem Schutz vor Überflutung, verstärkt jedoch innere Konflikte und Erschöpfung. Entwicklungsperspektivisch steht im Vordergrund, eine selbstführende innere Instanz zu stärken, die Angstanteile weder unterdrückt noch dominieren lässt, sondern regulierend und mitfühlend begleitet. Ziel ist eine zunehmende innere Sicherheit, unabhängig von äußeren Bedingungen, sowie eine klarere Abgrenzung zwischen Verantwortung für sich selbst und für andere. Einladungen (Todos, Aufgaben, Übungen): • Weiterführende Arbeit mit dem Modell der inneren Anteile (Differenzierung zwischen Angst-, Kontroll- und Selbstanteilen) • Erlaubnis, Anteile nicht „mögen“ zu müssen, ohne sie auszugrenzen • Stärkung innerer Selbstberuhigung und Selbstführung bei Angsterleben • Achtsames Wahrnehmen früher Prägungen und deren heutiger Wirkung • Überprüfung äußerer und innerer Sicherheitsstrategien auf ihre aktuelle Funktionalität
hat teilgenommen

--- Seite 6 ---

Seite 6 von 10Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

08.01.2026

Prozessreflexion14:00 - 15:30

orga produkt Info BL und PRs

hat teilgenommen

07.01.2026

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

Therap. B.Rüdiger, L.Lehmann (BQTlerin) Anfangsimpuls: Atembeobachtung, Trance Thema: Orientierung im Prozessverlauf, Umgang und in Beziehung setzen von inneren Anteilen , auch im Sinne der Regulation -Besonders: Wirkung der Beobachterposition beteiligte sich am Gruppenthema

hat teilgenommen

Gruppe non-verbal 214:00 - 15:40

Info z. Mth. für neue KlientInnen Musikalischer Impuls für die Gruppe zum Ankommen, in Resonanz gehen etc. >>> Austausch, Reflexion; wie bin ich da, was ging in Resonanz Improv.: Ausgangspunkt: wo stehe ich in meinem Prozess, was steht an etc. >> welchen Klang, Instrument.. könnte mich dabei unterstützen reflexion; bezüge zu einzelnen prozessen Abschluss: kurzes Aufgreifen des bedürfnisses nach Trommeln und der Möglichkeit , sich mehr zeigen zu dürfen und einen Umgang mit der Seite zu finden, die Sorge hat zu stören etc.... M.I.: Sehr mit der gruppe, den Anderen beschäftigt; es ihnen recht machen, nicht stören >> als ich sie darauf anspreche ("sich selbst zu vergessen") benennt sie auch, dass sie sich selbst nur ungern begegnen möchte.

hat teilgenommen

06.01.2026

Bezugsgruppe08:30 - 10:10

Therap.: L.Falke, L.Lehmann (BQTlerin) 1. Akkustand - Energielevel der Gruppe eingefangen 2. aktuelle Anliegen sammeln 3. Thema Grenzen 3.1. Impulse/Assoziationen sammeln 3.2. Übung zu Grenzen setzen und wahrnehmen 3.3. Austausch über Erleben in Übung M.I. Frau M sei mit 75% Energie gut in den Tag gestartet. Sie berichtet von erlebter Überforderung im Essensraum aufgrund der hohen Lautstärke, gleichzeitig sei dieses Erleben weniger gewesen am Abend, als sie selbst ruhiger in sich gewesen sei. Sie sei diesbezüglich im selbstständigen "Spiel mit ihrer Selbstregulierung". Grenzen setzen falle ihr bei Bekannten schwerer als bei fremden Personen, da sie in anderen keine schlechte Erfahrung erwirken wolle. Auch in der Übung erlebe sie es als schwierig die eigenen Grenzen wahrzunehmen, da sie stets beim Gegenüber sei. Gleichzeitig habe sie Erleichterung empfunden, wenn das gegenüber ihr Grenzen gesetzt habe. Dies würde ihre eigene Anspannung reduzieren, da sie nicht stets die Grenzen des anderen suchen müsse.

hat teilgenommen

05.01.2026

Bezugsgruppe mit Wochenausrichtung 08:30 - 10:30

Therap: B. Schmidt-Demir, B. Rüdiger, BQT lerin L. Lehmann Körperwahrnehmung Thema Haltung Ausrichtung
mittels Material Steine, Fr I.M. habe einen Stein für Harmonie gewählt, einen Anderen welcher Kantig sein
würde. Im Kantigen habe sie auch weiches entdecken können. das würde sie zur Sichtweise laden: alles darf
da sein, ohne das andere verändern zu müssen sie wolle statt zu werten ihren Bedürfnissen folgen.
hat teilgenommen

Körperarbeit Einzel (B. Schmitt) 15:30 - 16:15

Körperarbeit bei B. Schmitt Frau I.M. kommt aus der Medizin zu mir und habe dort mit der Mitarbeiterin
besprochen, dass sie das Thema hier bei mir einbringe. Seit Frau M. in der Klinik sei, werde ihr Auto regelm.
"bemalt". Zunächst habe sie versucht, das nicht ernst zu nehmen aber sie merke, dass sie dadurch mehr und
mehr in ein Angsterleben komme und nicht wisse, wie damit umgehen. Auch wenn man ihr vom med. Team
schon gesagt habe, dass man nichts tun könne, da es sich um einen öffentlichen Parkplatz handle. Biete Frau
M. an, dass ich die Info an das Team weitergebe. Es tue Frau M. gut, dass sie ernst genommen werde und
gleichzeitig wolle sie aber nicht, dass ihr Name genannt werde. Für heute hier gehe es ihr darum, wie sie mit
dem Angstanteil umgehen könne, zu schauen, um was für Themen es eigentlich gehe und nicht in ihr altes
Muster : "stell dich nicht so an" zu bedienen. Mit Hilfe des Anteilmodells entwickelt Frau M eigene Ideen, wie
sie z.B. im Anschluss an ihr Auto gehen könne und ihre Einjäufer erdige. Mit Abstand könne sie sehen, dass es
wichtig sei, die ängstliche Seite ernst zu nehmen aber nicht allein eine Entscheidung treffen zu lassen. Zu sehen,
dass sie auch eine coole, humorvolle und kluge Seite habe, das tue ihr gerade gut Und auch sich von mir
gesehen und ernst genommen zu fühlen. Sie könne gut gehen und bräuchte weiter nichts.

hat teilgenommen

02.01.2026

Bezugsgruppe 08:10 - 10:40

WE Bahnung Ideensammeln Einstieg: Gruppenarbeit zu gemeinsames Heimat. Gruppe gestaltet einen Insel,
Eigenraum, Verbindungen, Gemeinschaftsräume, Grenzen und Durchlässigkeiten werden erforscht. Freie
Arbeit Werkreflexion Entfaltet sich selbstbewusst im Gruppenbild, organische form entstehen über einen
großzügigen raum. Beim reflexion beobachtet sie wie dominant sie erscheine im Bild, wie saghaft ihr andere
beiträge erscheinen, dies wirke dann schnell um sie zu verunsichern, selbstzweifel entsteht. Gespräch danach,
wie sie sich mit unterschiede sich auseinander setzen kann ohne dabei sich in ängstliche lage zu bringen. Dies
hat teilgenommen

--- Seite 7 ---

Seite 7 von 10 Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

02.01.2026

schafft sie und geht in gute Verfassung aus den Raum.

31.12.2025

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

hat teilgenommen

30.12.2025

Prozessreflexion 08:45 - 10:15

Therapeut*innen: B. Rüdiger, L. Falke, C. Weber, H. Conrad, B. Schmitt -Demir Themen: Orga, PR, BL,
Gruppenwesen-Reflexion PR: hat in der letzte Woche ihr Angst erkannt. Am Anfang, sei sie davon überwältigt,
möchte aber in beziehung dazu bleiben und daran arbeiten. Frage von ther. Team zu überlegen wie wir sie
darin gut begleiten könnten.

hat teilgenommen

Körperarbeit Einzel (B. Schmitt) 10:45 - 11:30

Körperarbeit bei B. Schmitt Frau I.M. gehe es gerade nicht gut. Sie sei in einem starken Angsterleben
und fühle sich ohnmächtig. Biete ihr KÖA mit Ideen aus dem Anteilmodeel mit dem Fokus zum einen Abstand
zu den angstausschl. Bildern zu bekommen und einen sicheren Ort zu gestalten zu dem Frau M. immer wieder
innerlich gehen kann, wenn das Bedürfn. der Sicherheit gebraucht wird. Erlebe Frau M. dabei immer wieder
identif. mit einem ängstlichen (traumatis.?) Anteil. Die Arbeit mit abstrakten Bildern und immer wieder den
Fokus auf den Körper zu lenken (langsame Atmung, längere AA als EA) sei für Frau M hilfreich im Sinne einer

Art Pendelbewegung (weg vom Angsterleben hin zum sicheren Ort). Im Anschluss bei Herrn W. wolle Frau M. die konkrete Bedeutung / Inhalt des Bildes der "schwarzen Kiste mit dem Teufel/ Tod". sprechen. Sie könne gut gehen und sei von Suizid. distanziert.

hat teilgenommen

Einzelgespräch (C.Weber)11:45 - 12:35

Auftragsklärung Im Gespräch stand die vertiefende Auseinandersetzung mit inneren Anteilen und der damit verbundenen Angst im Mittelpunkt, insbesondere mit dem als „Tod“ benannten Anteil. Ziel war es, das veränderte innere Erleben weiter zu reflektieren, mögliche biografische Zusammenhänge zu explorieren und gemeinsam zu prüfen, wie Frau M. im aktuellen Prozess ausreichend Sicherheit und Stabilität gewährleisten kann. Relevante Gesprächsinhalte Frau M. berichtete, dass sie sich bereits seit längerer Zeit mit ihren psychischen Themen auseinandersetzt und aktuell ein zunehmendes Gefühl von Klarheit und innerem Verstehen erlebt. In therapiefreien Phasen, insbesondere an Wochenenden, bemerkte sie ein Zurückgleiten in alte Muster des Überspielens und der Distanzierung von sich selbst, was sie als unangenehm, zugleich aber als wichtigen Hinweis auf ihr Bedürfnis nach Halt und Begleitung wahrnimmt. Zentral war die Erfahrung, dass ein zuvor stark angstbesetzter innerer Anteil sein bedrohliches Erscheinungsbild verloren hat. Frau M. beschrieb, dass sie diesen Anteil früher als dunkles, dämonisches Monster erlebt hatte, inzwischen jedoch deutlich neutraler wahrnehmen kann. Die Benennung dieses Anteils als „Tod“ wurde als entlastend erlebt.

Unterstützend wirkten Gespräche mit ihrem Mann sowie die Auseinandersetzung mit Literatur zu inneren Anteilen und existenziellen Themen. Frau M. berichtete, dass ihre Angst vor dem eigenen Sterben deutlich geringer geworden sei. Im weiteren Verlauf konnte die Hypothese eines Traumahintergrundes vertieft werden. Frau M. schilderte eine Kindheit mit einem gewalttätigen, kontrollierenden und cholerischen Vater. Sie berichtete von nächtlichen Ängsten vor Monstern unter dem Bett, wobei die Zimmertür offen bleiben musste, damit der Vater Kontrolle ausüben konnte, und es keine Möglichkeit gab, die Eltern um Schutz oder Nähe zu bitten. Weiter beschrieb sie Situationen, in denen sie zu ihrem „eigenen Schutz“ im Zimmer eingesperrt wurde. Bei als unangemessen bewerteten Verhaltensweisen außerhalb der Familie musste sie einen dünnen Ast aus dem Garten schneiden, mit dem sie anschließend geschlagen wurde. Als ältestes Kind erlebte sie sich früh in einer versorgenden Rolle gegenüber ihren Geschwistern, während sie selbst niemanden hatte, der für sie da war. Frau M. reflektierte diese Erfahrungen differenziert und würdigte zugleich die Belastungen ihrer Eltern als Gastarbeiter ohne familiäres Unterstützungsnetz, beide berufstätig, mit der Leistung, die Kinder materiell zu versorgen und ihnen Bildungswege zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Eltern emotional nicht in der Lage waren, mit Gefühlen angemessen umzugehen, wodurch für Frau M. und ihre Geschwister traumatisierende Erfahrungen entstanden. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven Aus systemischer Perspektive lässt sich die Angst von Frau M. weniger als reine Furcht vor dem Tod verstehen, sondern vielmehr als Erwartung, mit Angst, Überforderung und existenziellen Gefühlen allein gelassen zu werden. Der innere Todesanteil kann hypothesenhaft als Symbol für frühe Erfahrungen von Ausgeliefertsein, Kontrollverlust und fehlender emotionaler Co-Regulation verstanden werden. Die Veränderung des inneren Bildes dieses Anteils deutet auf eine beginnende Integration traumatischer Erfahrungen und eine wachsende Fähigkeit zur Selbstberuhigung hin. Entwicklungsperspektivisch steht der Aufbau innerer Sicherheit im Vordergrund, insbesondere die Erfahrung, dass Frau M. heute nicht mehr allein bleiben muss, weder innerlich noch äußerlich. Einladungen Frau M. wurde eingeladen, weiterhin aufmerksam zu beobachten, wann sich der Todesanteil meldet und welche Bedürfnisse damit verbunden sind, insbesondere in Phasen reduzierter äußerer Struktur. Es wurde gemeinsam abgeklärt, wie sie aktuell für ausreichende Stabilität sorgen kann, falls die Auseinandersetzung mit den traumatischen Inhalten erneut intensiver wirken sollte. Dabei wurde betont, dass eine zeitweise Zunahme von Belastung sowohl gut erklärbar als auch angemessen sein kann. Frau M. wurde ermutigt, Selbstfürsorge, äußere Unterstützung und innere Kontaktaufnahme bewusst zu kombinieren und den Prozess in ihrem eigenen Tempo fortzusetzen.

hat teilgenommen

29.12.2025

--- Seite 8 ---

Seite 8 von 10Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

29.12.2025

Bezugsgruppe mit Wochenausrichtung 08:30 - 10:30

Therap: L.Falke, B.Rüdiger Karten auswählen zum Thema: hinter mir, Ausrichtung vor mir und eine Ressourcenkarte für den Menschen re von mir Fr I.M. Kartenwahl: Pferd -> tanzende Mädels sie würde Pferde nicht mögen, diese hätten so große Köpfe, das stünde für Starre, die sie gerne hinter sich lassen möchte, das tanzen sei dran für sie. Darüber käme sie zur Shensuch nach sich selbst, Ambivalenz zwischen Verpflichtung und Sehnsucht. welche Gewichtung?

hat teilgenommen

25.12.2025

Beratung - ausführlich (L.Schulze) 16:05 - 16:15

weint, möchte gerade nicht mehr alles aushalten müssen, wünscht sich pflanzliche medikamentöse Unterstützung. Zunächst beruhigende Worte, leidet vor allem unter der inneren Anspannung und Schlafstörung. Vorgeschlagen: Kyttä sedativum, Aurum/Lavendula Salbe für jetzt, Mg für jetzt, Bryophyllum dann auf Bestellung. Außerdem Mirtazapin als Möglichkeit der Hilfe angeboten und als Eskalationsstufe empfohlen und ggf. psych. konsil.

hat teilgenommen

24.12.2025

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

Therapeutinnen: B.Rüdiger, L.Falke Themen: Orga, Körperübung "Ich habe meinen Raum...", Blitzlicht mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage, Verabschiedung Herr Sch. // Einzeldoku: Frau M. habe gemerkt, dass sie am Morgen 'etwas für sich getan habe', das sei wertvoll. Sie käme sich vor wie eine Blumenwiese, und sehe diese wie ein Biene von Oben. Das Thema sei: wie könne sie auf sanfte Art Grenzen setzen?, klar werden und sein?

hat teilgenommen

23.12.2025

Bezugsgruppe 08:30 - 10:10

Thema: Erfahrungen mit dem Teilen seiner vermeintlichen Schwächen, Sicherheit durch Beschäftigung, Verabschiedung Herr H. Frau M. teilt ihre Erfahrung über das Vergleichen mit anderen und das Gefühl von Überforderung im Alltag.

hat teilgenommen

Einzelgespräch (C.Weber) 14:00 - 14:50

Auftragsklärung (Thema und Ziele des Gesprächs) Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Auseinandersetzung mit Frau M.s Angsterleben, insbesondere der Angst vor Krankheit, Kontrollverlust und Sterben, sowie ihrem Wunsch, freier und selbstbestimmter entscheiden zu können, ohne dass Angst leitend wirkt. Frau M. formulierte als zentrales Anliegen, ihre Angst besser zu verstehen, einen anderen Umgang mit ihr zu entwickeln und mehr innere Sicherheit aus sich selbst heraus zu gewinnen, anstatt diese primär im Außen zu suchen. Ziel des Gesprächs war es, aktuelle Erfahrungen aus dem Klinikalltag zu reflektieren, neue innere Erfahrungen zu würdigen und erste Schritte hin zu einer differenzierteren Beziehung zu ihren inneren Anteilen zu ermöglichen. Relevante Gesprächsinhalte Frau M. berichtete von positiven Erfahrungen im bisherigen Therapieprozess, insbesondere von Momenten, in denen sie sich selbst bewusster wahrnehmen und innerlich „bei sich sein“ konnte. Sie beschrieb, dass dies mit einer spürbaren Reduktion ihrer Angst einhergehe, ohne dass diese vollständig verschwinden müsse. Angst wurde von ihr zunehmend als innerer Zustand verstanden, der da sein darf und gleichzeitig regulierbar ist. Anhand konkreter Alltagssituationen (z. B. Angst vor einem Herzinfarkt nach dem Essen, Sicherheitsgedanken in Bezug auf den Hocker im Zimmer, Vermeidungs- und Kontrollimpulse) wurde deutlich, wie stark körperliche Symptome, gedankliche Katastrophisierungen und Sicherheitsverhalten miteinander verknüpft sind. Im Gespräch wurde ein inneres Spannungsfeld sichtbar zwischen einem ängstlichen, beschützenden Anteil, der auf Kontrolle, Vorsicht und Vermeidung ausgerichtet ist, und einem neugierigen, lebenszugewandten Anteil, der genießen, vertrauen und neue Erfahrungen zulassen möchte. Frau M. reflektierte, dass sie in früheren Lebensphasen stark auf andere angewiesen war, um Sicherheit zu erhalten, und dass Angst häufig Beziehung erzeugt habe. Gleichzeitig wurde deutlich, dass sie aktuell beginnt, Sicherheit zunehmend selbst herzustellen, was sich zunächst auch einsam anfühlen kann. Biografisch relevante Bezüge zeigten sich u. a. in familiären Lernerfahrungen, insbesondere im Vorbild der Mutter, die stark auf Vorsicht, Gefahrenvermeidung und vorausschauendes Handeln ausgerichtet war. Ebenso wurde eine frühere, sehr belastende Phase einer Angststörung thematisiert sowie der Suizid einer Tante väterlicherseits, der bei Frau M. intensive Ängste vor Kontrollverlust und „Entgleiten“ ausgelöst hatte. Frau M.

konnte zunehmend benennen, dass ihre „Uranst“ weniger die konkrete Krankheit, sondern vielmehr das Sterben selbst ist. Gleichzeitig zeigte sie die Fähigkeit, diese Angst einzuordnen, zu relativieren und sich selbst beruhigend zuzuwenden. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven Aus systemischer Sicht lässt sich die Angst von Frau M. als sinnvoller Schutz- und Beziehungsregulationsmechanismus verstehen, der in früheren Lebensphasen notwendig war, um mit Überforderung, existenzieller Unsicherheit und mangelnder emotionaler Spiegelung umzugehen. Die starke innere Kontrolle und das Sicherheitsverhalten könnten als Versuch gedeutet werden, innere Anteile oder Gefühle, die einst als überwältigend erlebt wurden, „in Schach zu halten“. Die im Gespräch eingeführte Arbeit mit inneren Anteilen eröffnet die Perspektive, diese Schutzmechanismen nicht länger zu bekämpfen, sondern in einen dialogischen Kontakt mit ihnen zu treten. Eine zentrale Entwicklungsperspektive liegt darin, dass Frau M. ihre Angst nicht mehr als feindlichen Fremdkörper erlebt, sondern als Teil ihrer inneren Organisation, der sowohl hilfreiche als auch einschränkende Funktionen hat. Durch die Stärkung einer übergeordneten Selbstposition kann sie lernen, zwischen berechtigter Vorsicht und hat teilgenommen

--- Seite 9 ---

Seite 9 von 10Verlaufsdokumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:40

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

23.12.2025

übermäßiger Angstreduktion zu unterscheiden und Entscheidungen zunehmend aus Selbstvertrauen statt aus Angst zu treffen. Langfristig könnte dies zu einer Integration bislang abgespaltener innerer Anteile beitragen und das Selbstwertgefühl stabilisieren. Die Fähigkeit, sich selbst emotional zu versorgen, scheint bereits angelegt und im aktuellen Setting weiter ausbaufähig. Einladungen (Todos, Aufgaben, Übungen) Frau M. wurde eingeladen, ihre im Alltag auftretenden Angstzustände weiterhin mit Neugier und einer innerlich zugewandten Haltung zu beobachten, statt sie sofort regulieren oder vermeiden zu wollen. Als unterstützend wurde angeregt, das Anteilemodell weiter zu erkunden, z. B. mithilfe der empfohlenen Lektüre („Reise in die Innenwelt“), um ein differenzierteres inneres Bild ihrer verschiedenen Anteile zu entwickeln. Zudem wurde sie eingeladen, im Klinikalltag bewusster auf ihre Grenzen zu achten und Selbstfürsorge nicht als „Nichtstun“, sondern als aktiven therapeutischen Prozess zu verstehen. Konkrete Übungen bestehen darin, in Angstmomenten innerlich Kontakt aufzunehmen (z. B. beruhigendes inneres Ansprechen des ängstlichen Anteils) und sich selbst Sicherheit zu geben, ohne vorschnell in Kontroll- oder Vermeidungsverhalten zu gehen. Ebenso wurde betont, den therapeutischen Prozessen Zeit zu geben und sich selbst zu erlauben, nicht „alles auf einmal“ verstehen oder bearbeiten zu müssen.

22.12.2025

Bezugsgruppe mit Wochenausrichtung08:30 - 10:30

Therapeutinnen: C. Saur, L.Falke Orga, Impuls: Trance mit inneren Helfer, anschließend Externalisierung durch Darstellung durch Tier/Symbol/Gegenstand und Positionierung im Raum, Besprechung des Wochenausblicks anhand dessen. // Einzeldoku: Frau M. zeige sich berührt vom Thema unerfüllter Kinderwunsch und berichte über ähnliche Gefühle. Zudem beschreibe sie prägende weibliche Bezugspersonen (Mutter, Großmutter), die für sie symbolisch für einen inneren „Löwen“ stünden. Für die kommende Woche äußere sie den Wunsch nach mehr Ruhe dieses inneren Anteils und vermehrter Entspannung.

hat teilgenommen

19.12.2025

Bezugsgruppe08:10 - 10:40

Orga WE Bahnung, Ideensammeln Einstieg: Malmeditation Hände führen eine Linie Freie Arbeit Werkreflexion Es sei ihr wichtig in der Meditation etwas schönes zum Ausdruck zu bringen, sie führe Linien nach oben aus, weint dabei und merke die Wut sei präsent. Sie kehrt zum Basis wieder und führt stabilisierende Linien dazu. Sie arbeitet weiter mit Farben am Bild. Die Arbeit sei intensiv und anstrengend aber es gefalle ihr. Sie erlebe Schwindel dabei, reguliert sich wieder in dem sie kleine nach oben steigende Blasen dazu malt. Die Arbeit sei für sie ein Gefühls Ausbruch die befreiend wirke.

hat teilgenommen

18.12.2025

Körperarbeit Einzel (B.Schmitt)09:00 - 09:45

Körperarbeit bei B.Schmitt-Demir Vorstellung und Produktinfo. Frau M. wünsche sich für den Aufenthalt, dass

sie mehr Selbstliebe für sich entwickeln könne. Auf der körperl. Ebene könne sie noch gar nicht sagen, was sie bräuchte oder ihr gut täte. Ganz sicher wären das aber gefühlsqualitäten wie Ruhe und Sicherheit. Biete ihr den Blick mit dem Anteilemodell an, was sie hilfreich erlebe. Damit könne sie gut gehen und versichern, dass sie von Suiz. distan. sei.

hat teilgenommen

Prozessreflexion 14:00 - 15:30

Therapeut*innen: Dr. M. Musterland, B. Schmitt, B. Rüdiger, L. Falke, H. Conrad Orga, BL, PR //

Einzeldoku: BL Thema: „Ankommen“. Sie beschrieb, dass sie sich im therapeutischen Setting zunehmend als ankommend erlebt und ein positives Gefühl dahingehend entwickelt, hier die von ihr gewünschte Unterstützung finden zu können. Zu Beginn des Aufenthalts beschäftigte sie die Frage nach Mindest- und Maximaldauer der Behandlungszeit sowie die Unsicherheit, woran sie sich zeitlich orientieren solle. Sie gelangte zu dem Entschluss, sich die Zeit zu nehmen, die sie individuell für ihren Prozess benötigt. Zudem äußerte sie, dass sie aufgrund eines Tinnitus zeitweise Schwierigkeiten habe, akustisch zu folgen.

hat teilgenommen

17.12.2025

Gruppe non-verbal 108:30 - 10:30

noch nicht angereist

hat nicht teilgenommen

Aufnahme Psychotherapie (C. Weber) 11:30 - 12:20

Auftragsklärung (Thema und Ziele des Gesprächs)

Im Erstgespräch stand die Therapieaufnahme sowie die gemeinsame Klärung des Anliegens der Klientin im Vordergrund. Die Klientin kommt mit dem Wunsch nach innerer Entlastung, emotionaler Selbstregulation und nachhaltiger Veränderung langjähriger Muster, die sie als stark belastend erlebt. Zentrale Ziele sind der bessere Umgang mit Angst, innerer Anspannung und Grübeln, das Reduzieren von Perfektionismus und Selbstabwertung sowie das Erlernen eines freundlicheren, akzeptierenden Umgangs mit sich selbst. Darüber hinaus formuliert die Klientin den Wunsch, sich selbst besser kennenzulernen, sich in Beziehungen weniger zurückzunehmen und eigene Bedürfnisse klarer wahrzunehmen und zu vertreten. Das Gespräch diente

hat teilgenommen

--- Seite 10 ---

Seite 10 von 10 Verlaufsdocumentation - Stand: 25.03.2026 14:53:41

Musterfrau, Marianne (A99001) Zi. 101

17.12.2025

außerdem dem Ankommen in der Klinik, der Herstellung von Sicherheit sowie der Einführung in das therapeutische Setting (Einzel- und Gruppentherapie). Relevante Gesprächsinhalte

Die Klientin berichtet von einer langen Leidensgeschichte mit Angstzuständen und depressiver Symptomatik. In früheren Phasen war sie stark eingeschränkt, bis hin zur Angst, das Haus zu verlassen oder längere Autofahrten zu unternehmen. Die aktuelle Anreise erlebte sie trotz innerer Ambivalenz (Angst, Erleichterung, Freude) als gelungen und als wichtigen Schritt. Körperlich beschreibt sie u. a. Schwindel und Nackenverspannungen, die sie selbst in Zusammenhang mit innerem Stress bringt. Emotional schildert die Klientin eine starke innere Dynamik: ein „Chaos“ aus gleichzeitigen Gefühlen, intensives Grübeln, innere Selbstkritik und das Gefühl, ständig etwas falsch zu machen. Sie beschreibt ausgeprägten Perfektionismus, hohe moralische Ansprüche an sich selbst sowie Schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Besonders belastend ist für sie der Umgang mit Wut und Ärger: Gefühle sind innerlich stark präsent, dürfen jedoch nach ihrer inneren Logik nicht gezeigt werden, was zu erheblicher Selbstabwertung und Erschöpfung führt. Biografisch deutet die Klientin an, dass sie im Elternhaus keinen hilfreichen Umgang mit Gefühlen gelernt hat. Beziehungen spielen eine zentrale Rolle: Das Thema der Eltern ist „groß“, ebenso die Beziehung zum Ehemann, der selbst aufgrund einer schweren Depression in stationärer Behandlung war. Die Klientin beschreibt viel Rücksichtnahme, Angst davor, andere – insbesondere den Ehemann – zu verletzen, und ein zunehmendes Zurücknehmen eigener Bedürfnisse, was langfristig zu Distanz und innerem Rückzug führt. Gleichzeitig besteht ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit und Motivation zur Veränderung. Die Klientin bringt bereits theoretisches Wissen (u. a. hypnosystemische Konzepte, Arbeit mit inneren Anteilen) mit, erlebt jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen Verstehen und Umsetzen. Im Gespräch zeigt sich ein hohes Maß an

Selbstbeobachtung, Humor und emotionaler Offenheit, bei gleichzeitiger innerer Überforderung. Die Klientin erlebt die Klinik als „safe place“ und fühlt sich zugehörig. Die Gruppe wird als möglicher Lern- und Spiegelraum eingeführt, was bei der Klientin sowohl Neugier als auch Respekt vor der Anstrengung auslöst. Hypothesen und Entwicklungsperspektiven

Aus systemischer Sicht lassen sich die Symptome der Klientin als Ausdruck eines langjährigen inneren Konflikts verstehen: Verschiedene innere Anteile verfolgen widersprüchliche Ziele (z. B. Kontrolle, Anpassung, Harmonie vs. Bedürfnis nach Authentizität, Abgrenzung und emotionalem Ausdruck). Insbesondere ein stark ausgeprägter, leistungs- und perfektionismusorientierter Anteil scheint dominierend und versucht, Sicherheit durch Kontrolle, Anpassung und Selbstkritik herzustellen. Gleichzeitig existieren verletzte, ängstliche und wütende Anteile, die wenig Raum bekommen und dadurch innerlich „lauter“ werden (Angst, körperliche Symptome, Grübeln). Die hohe Empathie und Rücksichtnahme der Klientin können als wertvolle Ressourcen verstanden werden, die sich jedoch in Selbstüberforderung verkehren, wenn die eigene Abgrenzung fehlt. Beziehungen – insbesondere zur Herkunftsfamilie und zum Ehemann – scheinen zentrale Resonanzräume zu sein, in denen alte Muster von Verantwortungsübernahme, Schuld und Angst vor Verletzung aktiviert werden. Die depressive und ängstliche Symptomatik kann hypothesengeleitet als Signal des Systems verstanden werden, dass bisherige Lösungsstrategien (Aushalten, Perfektionismus, emotionale Unterdrückung) nicht mehr tragfähig sind. Entwicklungsperspektivisch bietet insbesondere die Gruppentherapie einen zentralen Lernraum: Die Klientin kann dort ihre vertrauten Muster im Hier-und-Jetzt erkennen und alternative Erfahrungen machen, z. B. Bedürfnisse zu äußern, Gefühle wahrzunehmen, ohne sich dafür zu verurteilen, und Kontakt auch unter Bedingungen von Verletzbarkeit zu erleben. Langfristig erscheint eine Stärkung der Selbstbeziehung, der inneren Kooperation zwischen Anteilen sowie eine Erweiterung des Handlungsspielraums im Umgang mit Emotionen und Nähe-Distanz-Regulation als zentral. Einladungen (Todos, Aufgaben, Übungen)

Die Klientin wird eingeladen, sich bewusst Zeit für das Ankommen zu nehmen und inneren Leistungsdruck („jetzt muss etwas passieren“) wahrzunehmen, ohne ihm sofort zu folgen. Als erste Übung wird angeregt, Gefühle nicht zu bewerten oder zu bekämpfen, sondern innerlich zu benennen (z. B. „Ein Teil von mir ist ängstlich, ein anderer freut sich“) und mehrere Emotionen gleichzeitig zuzulassen. Im Gruppen- und Einzelsetting wird die Klientin eingeladen, wahrzunehmen, wann sie beginnt „auszuhalten“, sich zurückzunehmen oder sich selbst zu kritisieren, und diese inneren Prozesse – wenn möglich – mitzuteilen. Eine weitere Einladung besteht darin, neugierig auf die eigenen inneren Anteile zu werden, insbesondere auf den sehr bemühten, perfektionistischen Anteil, und dessen positive Absicht zu würdigen, ohne ihm automatisch die Führung zu überlassen. Im Kontakt mit anderen (Gruppe, Ehemann) wird die Klientin eingeladen zu experimentieren, Gefühle zunächst innerlich anzuerkennen, bevor sie über angemessene Ausdrucksformen entscheidet. Perspektivisch kann – je nach Verlauf – ein gemeinsames Gespräch mit dem Ehemann als unterstützende Intervention geprüft werden, mit dem Fokus darauf, wie er den Prozess der Klientin begleiten kann. Insgesamt wird die Klientin eingeladen, sich selbst mit mehr Freundlichkeit, Geduld und Humor zu begegnen und Veränderung nicht als Leistung, sondern als Beziehungsgeschehen – insbesondere zu sich selbst – zu verstehen.

Gruppe non-verbal 214:00 - 15:40

Musik am Anfang Thema Abschied - von einer Mitkli. von mir - Stille Welches Bedürfnis steht hinter der Stille ?
Sanftheit - Verdauung - Musik Klangliege Abschluss mit Umarmungen
hat nicht teilgenommen